Nordsjællands Hospital
Neurologisk afdeling

Ernæring og patientcentreret sygepleje

Jacob Mesot Liljehult
Klinisk sygeplejespecialist
cand.scient.san, PhD

Ikke et nyt problem



”Enhver omhyggelig iagttager af syge vil kunne skrive under på, at der midt i vores overflod hvert eneste år dør tusinder af patienter af sult, fordi man ikke er opmærksom på de fremgangsmåder, uden hvilken de ikke kan tage føde til sig.”

Florence Nightingale, 1859

Hvorfor er ernæring vigtigt?



Patienterne synes det er vigtigt
Øget livskvalitet



Forbedre effekten af behandlingen, forebygger komplikationer, øget funktion



Kortere indlæggelse, mindre ressourceforbrug, mindre økonomiske udgifter, organisatorisk krav

Ernæringsproblemer



Underernæring

Muskelatrofi, nedsat immunforsvar, øget dødelighed

Dysfagi

Risiko for kvælning og aspiration til luftvejene

Nedsat madindtag

Træthed og underernæring

Øget energi- og proteinbehov

Øget forbrug ved alvorlig sygdom

Billede: Colourbox

Hvordan bliver ernæring et problem?

Patientfaktorer

- Nedsat bevidsthed
- Appetit, madlede, ændret smagssans
- Kvalme / opkastning
- Mundtørhed og tandstatus
- Problemer med at tygge eller synke maden
- Øget energibehov
- Kognitive problemer, *fx apraksi, hukommelse, opmærksomhed*



Billede: Colourbox

Hvordan bliver ernæring et problem?



Hospitalsfaktorer

Faste

Dårlige omgivelser, *fx støj, lugte, mangel på plads*

Undersøgelser, procedurer, stuegang, transport

Tilgængelighed, *fx rigide spisetider, lille sortiment*

Hensyn til præferencer, allergier, vaner

Viden og prioritet hos personalet

Billede: Region Hovedstaden

Neurologiske patienter

- Nedsat bevidsthed
- Dysfagi
- Motorik og følesans
- Apraksi
- Syn og visuo-spartiel perception
- Opmærksomhed



Billede: Colourbox

Nedsat bevidsthed



Synkerefleksen ophører

Hosterefleksen svækkes eller ophører

Stor risiko for fejlsynkning og aspiration til luftvejene

Billede: Colourbox

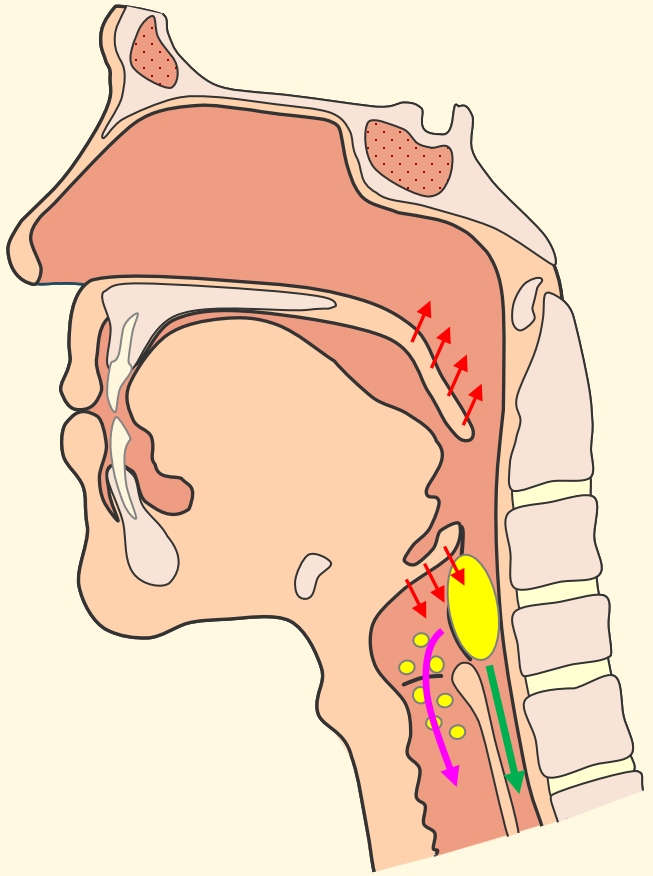
Dysfagi

Nedsat følelse i svælget

Nedsat aktivering af svælgmusklerne

Symptomer:
Hoste, våd stemme, forsinket synk

Risiko for aspiration til luftvejene og kvælning



Billede: Jacob Liljehult

Apraksi



- Vanskeligheder med at udfører praktiske opgaver
- Latenstid, tøvende og klodset, perseveration
- Hænger ofte sammen med afasi
- Hyppigst hos patienter med skader i venstre hemisfære (frontalt eller paritalt)

Billede: Colourbox

Apraksi

Idiomotorisk

Problemer med at koble den rigtige bevægelse til aktiviteten

fx at føre skeen op til munden

Ideatorisk

Problemer med sekvensen af del-elementer af en aktivitet

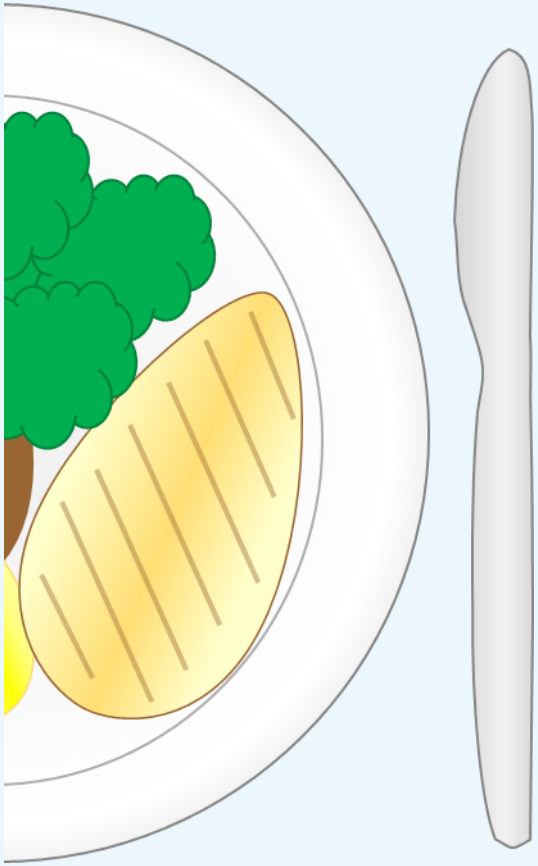
fx at puste på varm mad før det puttes i munden

Konceptuelt

Problemer med at anvende genstande korrekt

fx prøver at spise suppe med gaflen

Syn og visuospartiel perception



Neglekt/inattention
Opfatter ikke halvdelen af opgivelserne (perceptorisk)

Hemianopsi
Kan ikke se halvdelen af synsfeltet (sensorisk)

Rumlig opfattelse
Har svært ved at finde genstande i synsfeltet (perceptorisk)

Agnosi
Kan ikke genkende genstande (perceptorisk)

Billede: Jacob Liljehult

Motorik og følesans

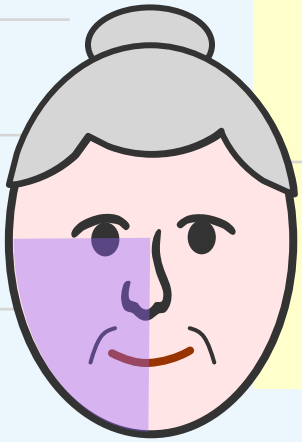
Lammelse / styrings-besvær i arme og hænder

Lammelse i ansigtet faciales parese

Nedsat følelse i ansigtet

Lammelse i tunge og svælg

Bid / sår i tunge og kind



Problemer med at holde og styre mad i munden

Risiko for at bide sig selv

Problemer med at rense munden

Billede: Jacob Liljehult

Opmærksomhed



Problemer med at holde opmærksomhed under måltidet

Svært ved at overskue flere ting på en gang

Opmærksomheden afledes let fra maden

Patienter med delirium har ofte forstyrret opmærksomhed

Billede: ChatGPT

Hvordan finder vi ud af om der er et problem?

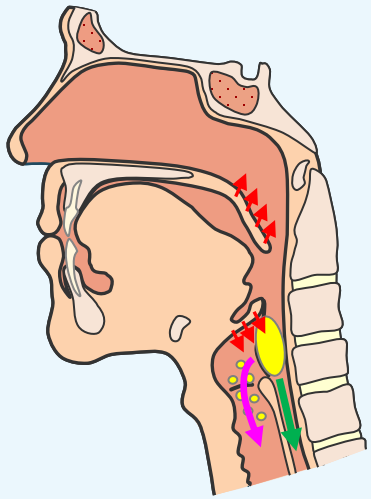
Ernærings-tilstand

Ernærings-screening
Klinisk vurdering



Synke-funktion

GUSS-test



Allergier og præferencer

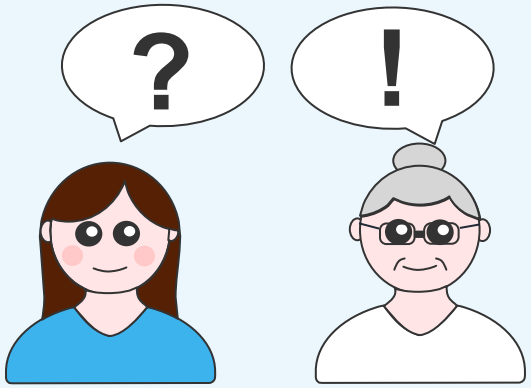


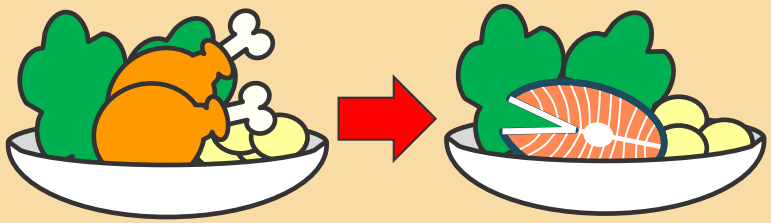
Illustration: Jacob Liljehult

Løsninger

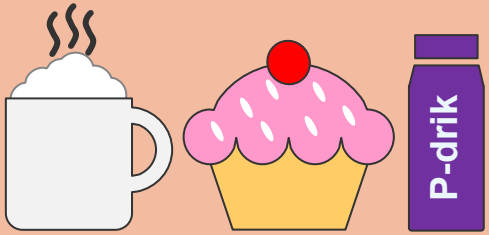
Dialog med patienten



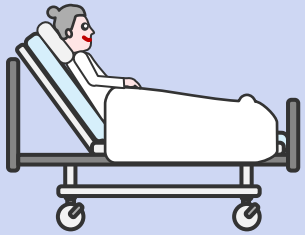
Tilpasning af kosten



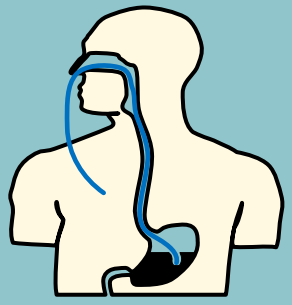
Mellemmåltider



Tilpasning af omgivelserne



Sonde



Sund kost













Billede: Colourbox



Billede: Colourbox

Oplæg til gruppeøvelse

1. **Beskriv patientens ernæringsproblem**
   - Symptom: *Hvilke tegn viser at der er et problem?*
   - Årsag: *Hvordan er problemet opstået?*
   - Problem: *Hvilket problem skal løses?*
2. **Lav en plan for patientens ernæring**
   - *Hvilke interventioner vil I starte for at sikre at patienten får nok ernæring?*
   - *Hvilke samarbejdspartnere skal involveres?*
3. **Hvordan vil I evaluere planen?**
   - *Hvordan følger vi op på problemet?*

Snak sammen omkring bordet og udfyld skemaet

Fortæl jeres plan i plenum

Case 1: Kirsten, 85 år



Enke, bor alene, hjemmehjælp x 3
Kendt med Parkinson
Indlagt til medicin regulering pga faldende funktion og øget rigiditet.
Flere fald i hjemmet.
Vægttab på ~8 kg over 6 mdr
(Nuværende vægt 49 kg)

Billede: Colourbox

Case 2: Poul, 67 år



Bor i hus med hustru, pensioneret håndværker
Faldet om i soveværelset med nedsat bevidsthed og svær venstresidig hemiparese.
CT har vist ICH i basal ganglie.
På 2. døgn fortsat GCS 11

Billede: Colourbox

Case 3: Henrik, 61 år



Faldet på cykel i skoven. CT har vist kraniefraktur, men ingen blødning.
Klager over at han bliver ved med at få sit spyt galt i halsen.
Ved GUSS-test hoster han, selvom vandet er meget fortykket

Billede: Colourbox

Case 4: Inge, 80 år



Indlagt obs TCI efter tre episoder med sovende følelse og styrings-besvær i højre arm.
Kendt multiallergiker – bla. overfor gulerødder, tomat, pederfrugt, forskellige nødder, rå æbler.
Tidligere indlagt med vejrtrænings-besvær efter hvepsestik

Billede: Colourbox

Case 5: Agnes, 87 år



Indlagt fordi hjemmeplejen synes hun var mere forvirret en vanligt.
CT har vist et mindre kronisk SDH.
Sovet sparsom de sidste tre nætter og er motorisk urolig og pillende.
Indimellem synshallucinationer.
Spiser og drikker sparsomt, fordi hun let mister opmærksomheden.

Billede: Colourbox

Case 6: Birgit, 72 år



Indlagt med absces i hjernen efter hjerteklap operation og er opstartet 3-stof antibiotikabehandling.
Har nedsat appetit, får kvalme når hun spiser, synes maden smager underligt og hun føler sig tør i munden.

Billede: Colourbox

